

Asignatura: Salud del niño, niña y adolescente

Guia para el estudiante

Módulo Neonatal: Primera parte

*“Para cambiar al mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer”
(Michel Odent)*



Módulo Neonatal

Contenidos:

Lectura y análisis de Historia clínica perinatal del CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología) y factores de riesgo perinatales. Preparación para el parto. Nacimiento y recepción de la persona recién nacida sana. Primera hora de vida. Apgar. Examen físico de la persona recién nacida. Profilaxis de patologías neonatales. Microbiota. Pesquisas recomendadas: Enfermedades metabólicas congénitas. Cardiopatías congénitas. Hipoacusia. Reflejo rojo. Displasia luxante de cadera. Lactancia. Puericultura. Recomendaciones al alta.

Fecha : 25 y 27 de marzo de 2026

Objetivo general:

- Adquirir habilidades clínicas y comunicacionales para la atención integral de personas recién nacidas de término, sanas y vigorosas, la madre y la familia durante el proceso de nacimiento.

Objetivos específicos:

- Identificar los factores perinatales de relevancia en el nacimiento de una persona recién nacida.
- Distinguir las acciones del equipo de salud dependientes e independientes del tiempo, justificando la priorización de las primeras.
- Realizar las acciones sensibles al tiempo de la primera hora de vida: puesta al pecho precoz, contacto piel a piel, clampeo oportuno o tardío de cordón umbilical.
- Identificar los factores protectores para el establecimiento de un microbioma saludable.
- Identificar y describir las condiciones obstétricas neonatales esenciales (CONE)
- Desarrollar una mirada crítica de los procesos de trabajo vinculados al nacimiento y al respeto de los derechos de las personas recién nacidas y sus familias.
- Detallar los pasos del examen físico de personas recién nacidas a término, sanas.
- Describir las rutinas que previenen complicaciones posteriores (profilaxis) justificando su procedencia.
- Conocer las pesquisas recomendadas en el recién nacido
- Realizar recomendaciones al alta del recién nacido, acerca de sueño, lactancia, accidentes, higiene, etc
- Clasificar los distintos tipos de ictericia neonatal, utilizar las curvas de luminoterapia e indicar tratamiento.

-Bibliografía Obligatoria:

- Apartado resumen Historia Clínica Perinatal. Disponible en:
 Historia clinica perinatal abreviada para LHC.docx.pdf
- CONDICIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES ESENCIALES.(CONE) Anexo a Resolución del MSN. Año 2018
- Consenso La Primera Hora de Vida. Unicef. Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en:
<https://www.unicef.org/argentina/media/16066/file/La%20primera%20hora%20de%20vida.pdf>
- Lic. Marianela Balanesi, Dra. Guadalupe García Monlezun, Dra. Martina Cisneros. Módulo Neonatal. Afecciones Perinatales. 2. 1. Situaciones problemas con reflexiones. La Red SaNNA. p.122-128. Disponible en: <https://redsanna.org/publicaciones-2/>
- Prof. Carlos Deguer. **¿Qué debe saber un/a pediatra sobre el examen físico de recién nacidos/as?** Reichenbach J. La Hora de Oro en Pediatría. Vol 1. 1° ed. La Plata: FEMEBA; 2018. p. 49-58
- Dr. Miguel Larguía. El microbioma intestinal del lactante. Capítulo 1. Módulo 2. Pronap 2017.
- Algoritmo recepción disponible en:
https://www.sap.org.ar/docs/pdf/files_algoritmorcpneo11-22_1669216804.pdf
- Sociedad Argentina de Pediatría. (2025). *Guía para consulta prenatal de embarazos de bajo riesgo*. Comité de Pediatría Ambulatoria & Comité de Estudios Feto-neonatales (CEFEN). Disponible en:
<https://sub.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/688/a1f/575/688a1f575502c22458305>

[9.pdf](#)

- Chattas G. Cuidados al recién nacido en el periodo de transición. Rev. Enferm. Neonatal ; pag 3-7, 2007. Disponible en:
<https://dn790000.ca.archive.org/0/items/cuidados-al-recien-nacido-en-el-periodo-de-transicion/Cuidados%20al%20reci%C3%A9n%20nacido%20en%20el%20periodo%20de%20transici%C3%B3n.pdf>
- Las siete enfermedades pesquisadas. Fundación de endocrinología infantil (FEI). Disponible en: <https://fei.org.ar/enfermedades-pesquisadas/>
- Santos Norberto E, en Reichenbach JA. “La hora de oro en Pediatría”, V. 1, “Ictericia Neonatal”, p. 113-123. 2018

Estudiantes:

★ Traer impresa Historia clínica perinatal del CLAP (pág 2) completa con los datos del caso clínico y traer resuelta la guía.

Esta es la historia de Pedro, iremos trabajando con las distintas etapas que van a ir sucediendo desde su nacimiento hasta los primeros días de vida.

Primero: Trabajamos con la historia clínica perinatal.

Camila Juarez de 30 años, fecha de nacimiento 3/3/1996. Vive con su esposo Anibal de 33 años, en Ayacucho 4545, localidad de Mar del Plata. Ella es arquitecta. La mamá de Camila tiene HTA y diabetes. Ella no tiene antecedentes de relevancia. Si nos cuenta que a los 26 años tuvo un aborto en el 2do mes de embarazo. Este embarazo fue planeado por lo que ella hizo todos los controles necesarios (tiene 8 controles hasta la fecha). Su primer control gineco obstétrico y de ecografía fue a las 6 semanas de embarazo. Presenta serologías negativas, excepto toxoplasmosis + pasada. No fuma, ni toma alcohol, ni consume drogas. Vacunas: completas. Pesa 68 kg Talla: 1,60 mt, FUM 20/6/2025 FPP 26/3/2026. No toma hierro (hb 13 g/dl a las 24 sem). Camila y su marido son G y F: A Rh(+). Ella se realizó el hisopado vaginal para streptococcus agalactiae en la sem 37 y dio negativo, gesta de 39 semanas por FUM y eco, posición cefálica. En el día de la fecha, ingresa a la guardia Camila con trabajo de parto. Está por nacer Pedro !!!

1) Identifique los datos maternos relevantes para el nacimiento y complete la historia clínica perinatal. ¿Por que cree que algunos puntos estan marcados con amarillo?

2) Si Ud tuviera que transmitir al neonatólogo/a que recibirá al recién nacido los datos más importantes de la historia clínica de la embarazada, ¿cómo transmitirá esa información ?

EJEMPLO: Lucia tuvo un embarazo controlado, primera gesta, serologías negativas, hisopado vaginal strep agalactiae positivo, sin ninguna complicación. Grupo y factor A RH (-)

3) ¿De qué hablamos cuando hablamos de condiciones obstétricas neonatales esenciales (CONE)? Expliquelas.

En el día de la fecha nace Pedro a las 11:20 hs, por parto vaginal, la madre no presentó ninguna complicación y el niño fue un recién nacido vigoroso. Lloro apenas nació, respira con adecuado esfuerzo respiratorio sin uso de músculos accesorios. Presenta un tono flexor en los 4 miembros, frecuencia cardíaca de 130 x min. Color cianótico que se vuelve rosado a los 2 minutos de vida. Adecuada adaptación a la vida extrauterina. Apgar 9/10. EG: 39 sem. Se ligó el cordón cuando dejó de latir, luego realizó COPAP y la madre le pudo dar el pecho antes de la primera hora. Luego de unas horas se toma el Peso 3500 kg (PAEG), Talla 50 cm y PC 35 cm.

4) Repasemos lo visto en NCD. Explique la **transición normal cardiorrespiratoria de la vida intrauterina a la vida extrauterina** que atravesó Pedro.

Cuadro 1: Diferencias entre la circulación fetal y la postneonatal				
	Circuitos	Resistencia vascular	Intercambio de Oxígeno y CO ₂	Shunts o comunicaciones
FETAL	En paralelo	Pulmonar mayor que la sistémica	Se realiza en placenta	Conducto venoso. Conducto arterioso. Foramen oval
POSTNATAL	En serie	Sistémica mayor que la pulmonar	Se realiza en el pulmón del recién nacido	Ninguna

5) ¿Cuáles son las **preguntas que nos realizamos para saber si debemos iniciar con maniobras de reanimación** luego del nacimiento de un niño?

Algoritmo de Reanimación Neonatal en Sala de Partos 2022



Disponible en:

https://www.sap.org.ar/docs/pdf/files_algoritmorcpneo11-22_1669216804.pdf

6) ¿Por qué decimos que Pedro es un **recién nacido vigoroso** y qué conducta se toma posterior a su nacimiento?

7) ¿Cuáles son las **prácticas y los beneficios de la hora sagrada** o primera hora de vida? ¿A que se llama **acciones dependientes e independientes** del tiempo? ¿Cuáles son sus **contraindicaciones**?

8) Describa el puntaje de **Apgar**, momento de su realización y que predice. ¿Qué diferencia hay con las preguntas que se realizan inmediatamente al nacimiento? ¿Por qué crees que Pedro tiene Apgar 9/10?

PUNTUACIÓN DE APGAR				Edad gestacional		Semanas			
SIGNO	0	1	2	1 minuto	5 minutos	10 minutos	15 minutos	20 minutos	
Color	Azul o pálido	Acrocianosis	Totalmente rosado						
Frecuencia cardíaca	Ausente	< 100/minuto	> 100/minuto						
Irritabilidad refleja	Sin respuesta	Muecas	Llanto o retirada activa						
Tono muscular	Flácido	Ligera flexión	Movimiento activo						
Respiración	Ausente	Llanto débil, hipoventilación	Llanto enérgico						
Comentarios				Reanimación					
				Minutos	1	5	10	15	20
				Oxígeno					
				VPP/NCPAP					
				TET					
				Masaje cardíaco					
				Adrenalina					

Fig. 1. Impreso ampliado de puntuación de Apgar. Registrar la puntuación en el lugar oportuno a los intervalos de tiempo indicados. Las medidas adicionales de reanimación (si son oportunas) se registran al mismo tiempo que se notifica la puntuación marcando en la casilla oportuna. Utilizar el recuadro de comentarios para citar otros factores, como las medicaciones maternas, la respuesta a la reanimación entre los momentos de registro de la puntuación, o ambos.

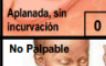
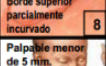
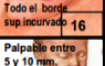
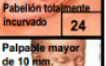
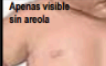
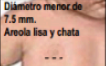
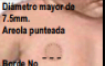
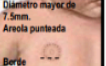
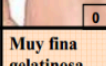
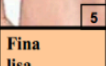
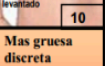
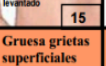
9) ¿Cómo se clasifican a los recién nacidos según la **edad gestacional**? y ¿según el **peso**? ¿Cómo sería en el caso de Pedro?

10) Describa ¿que debemos tener en cuenta al **realizar el examen físico** de Pedro, que evaluamos y en qué **momento** deberíamos realizarlo?

11) Al examen físico, Pedro presenta estas características.:

- Forma de la oreja (pabellón): todo el borde superior incurvado
- Tamaño de la glándula mamaria: palpable 9 mm
- Formación del pezón: diámetro de 8mm, areola punteada borde NO levantado
- Textura de la piel: gruesa grietas superficiales, descamación de manos y pies
- Pliegues plantares: surcos en la mitad anterior

Utilice el **MÉTODO CAPURRO** y calcule la **edad gestacional de Pedro**.

Forma de la OREJA (Pabellón)	 Aplanada, sin incurvación 0	 Borde superior parcialmente incurvado 8	 Todo el borde superior incurvado 16	 Pabellón totalmente incurvado 24	
Tamaño de GLÁNDULA MAMARIA	 No Palpable 0	 Palpable menos de 5 mm. 5	 Palpable entre 5 y 10 mm. 10	 Palpable mayor de 10 mm. 15	
Formación del PEZON	 Apenas visible sin areola 0	 Diámetro menor de 7.5 mm. Areola lisa y chata 5	 Diámetro mayor de 7.5 mm. Areola punteada 10	 Diámetro mayor de 7.5 mm. Areola punteada 15	
TEXTURA de la PIEL	 Muy fina gelatinosa 0	 Fina lisa 5	 Mas gruesa discreta descamación superficial 10	 Gruesa grietas superficiales descamación de manos y pies 15	 Gruesa grietas profundas aparaminadas 20
PLIEGUES PLANTARES	 Sin pliegues 0	 Marcas mal definidas en la mitad anterior 5	 Marcas bien definidas en la 1/2 anterior, Surcos en 1/2 anterior 10	 Surcos en la mitad anterior 15	 Surcos en mas de la mitad anterior 20

$$\text{EDAD GESTACIONAL} = \frac{\text{ED} = 204 + \text{PUNTAJE}}{7}$$

$$\text{EJEMPLO: } \frac{204 + 56}{7} = 37.1 \text{ SEMANAS}$$

- 11) Con todos los datos obtenidos de Pedro, **completamos la historia clínica**.
 12) Pedro recibe la **triple profilaxis**. ¿A que se refiere este término y qué estamos previniendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de **tetanalgesia**?
 13) ¿Cómo crees que impactará el tipo de nacimiento y la alimentación en la **microbiota** de Pedro?

Pedro hace 72 hs que está internado junto a su madre (internación conjunta).

Al examen físico se encuentra normohidratado, normoperfundido, en suficiencia cardiorrespiratoria. R1 y R2 normofonéticos en 4 focos, silencios impresionan libres. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Abdomen blando depresible indoloro RHA + Diuresis: moja más de 5 pañales al día. Catarsis: 1er día meconio, hoy las deposiciones son más líquidas y amarillentas. Peso: 3.325 Kg. Succión vigorosa con buena prendida.

- 14) Usted como médico, está preparando todos los papeles para el alta del niño. La mamá de Pedro está preocupada porque él bajó de peso. **Calcule el porcentaje de descenso**. ¿Qué **conducta** toma con el niño? ¿cómo le explica a la madre?

Fórmula de cálculo de porcentaje de descenso de peso:

Peso de nacimiento: xxx-----100%

Peso actual xxx-----xx%

Luego hacemos una resta de 100% - xx% = nos da el % de descenso de peso

- 15) ¿**Qué pesquisas deben realizarle a Pedro antes del alta**? Explíquelas brevemente. Mencione cada una de ellas, que se busca en las mismas y si existen Leyes o Programas que recomienden su realización.
 16) Antes del alta de Pedro, debemos darle a los padres **las recomendaciones** pertinentes. **Complete el cuadro**.

RECOMENDACIÓN	¿ qué le decimos a la madre/ padre/ pareja?	RECOMENDACIÓN	¿ qué le decimos a la madre/padre/pareja?
LACTANCIA		PAUTAS DE ALARMA	
DIURESIS		VACUNAS Y CUIDADOS	

CATARSIS		BAÑO	
SUEÑO SEGURO		APEGO Y ESTIMULACIÓN	
CUIDADO DEL CORDÓN		VISITAS Y VIDA SOCIAL	
PANTALLAS		PRÓXIMO TURNO	

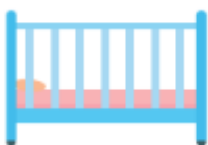
RECOMENDACIONES PARA EL RECIÉN NACIDO TRAS ALTA HOSPITALARIA

EL CORDÓN UMBILICAL

- La zona debe estar **siempre limpia y seca**. No tiene que aplicar desinfectantes, a no ser que sea por prescripción médica.
- No aplicar polvos ni cremas.
- El cordón suele caer entre siete y catorce días después del nacimiento.
- Signos de alerta: Salida de líquido, mal olor, enrojecimiento, inflamación.

SUEÑO

- La posición recomendada para el sueño del recién nacido es **boca arriba con la cabeza girada hacia un lado** para evitar riesgo de muerte súbita en el lactante.
- Se deberá **colocar los pies del recién nacido tocando la parte baja de la cuna**.
- No se deben utilizar cojines para dormir.
- Se tienen que **retirar los peluches y las mantas** de la cuna.



HOGAR Y VISITAS

- Los recién nacidos tienen un **riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas**. Para evitarlo es importante tomar algunas medidas higiénicas:
 - Es recomendable **lavarse las manos** con frecuencia.
 - No se recomienda **reunir mucha gente** en torno al bebé.
 - Se debe **evitar el contacto con personas resfriadas** ni con enfermedades contagiosas.

SALIDAS Y PASEO

- El recién nacido **puede salir de paseo**, pero es aconsejable **evitar los lugares con mucha aglomeración** y/o con presencia de humo o polución.
- Siempre **evitar fumar** junto al bebé.



- En verano, **evitar las horas de más calor** para las salidas o paseos.
- En coche se tiene que **utilizar siempre las sillas homologadas**. Así como se tiene que **evitar hacer viajes de más de una hora** en los primeros días o semanas. Y, el bebé siempre tiene que estar bajo vigilancia.

LA HIGIENE

EL BAÑO DEL RECIÉN NACIDO

- **No está recomendado** antes de la caída del cordón umbilical.
- Se recomiendan **baños cortos** con jabón de un pH **neutro**.
- Se **deberá secar la piel con cuidado** e insistiendo en los pliegues.
- La temperatura del agua recomendada es de **36-37 °C**.
- Se debe **sujetar al bebé con suavidad, pero con firmeza** apoyando las nalgas y sosteniendo con nuestro brazo y mano su espalda y cabeza.
- **No se deben utilizar colonias ni polvo de talco** sobre la piel del recién nacido.



LA PIEL

- En el recién nacido **la piel es suave y delicada**. Le afecta tanto el frío como el calor, pero tienen una protección natural para ello.
- Toda la **ropa** que entre en contacto con su piel, es aconsejable que **sea de algodón**.
- Se debe tener **especial cuidado con las nalgas y los pliegues**, ya que se irritan con facilidad debido a una mezcla de calor y humedad que se acumula en el pañal.
- Por este motivo hay que **cambiarlo con frecuencia**. Esta zona **debe limpiarse y secarse bien después de cada micción y/o deposición**.



CAMBIO DE PAÑAL

- Se debe **cambiar frecuentemente** para preservar la integridad de la piel. A las niñas se recomienda **limpiar zona genital de adelante hacia atrás**.
- **No se recomienda el uso habitual de toallitas**, es preferible lavar con agua y jabón de pH neutro.



EL CABELLO

- Se debe **lavar suavemente**.
- **No es necesario** utilizar **jabón** cada día.
- **Secar inmediatamente** y con cuidado.
- Si la cantidad de cabello lo requiere, dar un ligero masaje con un **peine especial para bebés**.



LAS UÑAS

- En el recién nacido **son muy frágiles** y tienden a romperse espontáneamente.
- **No se recomienda utilizar tijeras** para cortar las uñas hasta que el pediatra lo autorice, pero sí está recomendado usar limas de cristal.



LOS OÍDOS

- El **cerumen** que sale del interior **protege el conducto auditivo y lo mantiene limpio**.
- Se tiene que **limpiar únicamente la parte externa** del pabellón auricular con una gasa seca.
- **No utilice bastoncillos** que podrían producir lesiones en el conducto auditivo.

LA BOCA

- No requiere ningún cuidado especial.
- Si aparecen **manchas blancas denominadas muguet** en el paladar y las encías, el recién nacido debe ser **inspeccionado por el pediatra**.

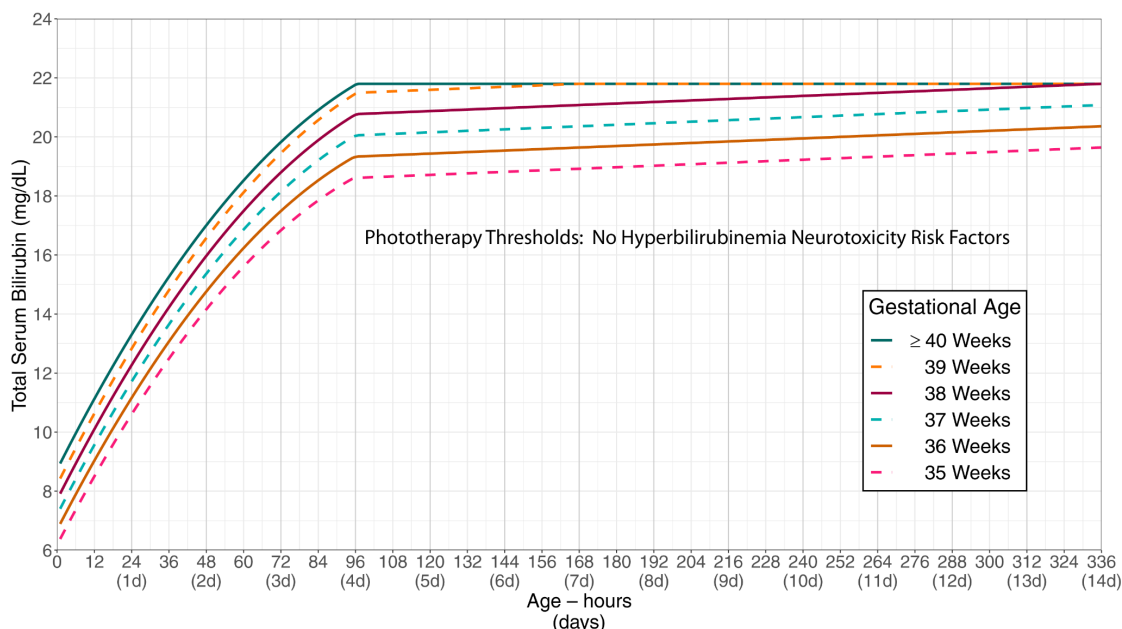
Usted recibe a **Pedro a los 6 días de vida**, para su **primer control por consultorio**. La mamá se encuentra angustiada porque dice que llora mucho y que a veces no puede despertarlo para darle la teta, que le duele mucho al dar el pecho porque tiene grietas en un pezón. Usted se dispone a tranquilizarla, toma al bebé y lo comienza a revisar. Al examen físico constata ictericia en conjuntivas, cara, tronco y abdomen y un peso de 3.400 grs. El bebé se encuentra reactivo, en buen estado general, moja entre dos y seis pañales por día y presenta deposiciones amarillentas. Normohidratado. Usted **solicita el siguiente laboratorio** que indica una bilirrubina total de 7 mg/dl, bilirrubina indirecta de 6,5 mg/dl, bilirrubina directa 0,5 mg/dl, Hto 48%, GyF A Rh +

17) Con respecto a la anamnesis y examen físico que el paciente presenta, cuál sería su **impresión diagnóstica**?

18) Interprete los valores del **laboratorio**. ¿Usted considera que la **causa de sus sospecha diagnostica** es fisiológica o patológica? **Describa los mecanismos** por los que aparece

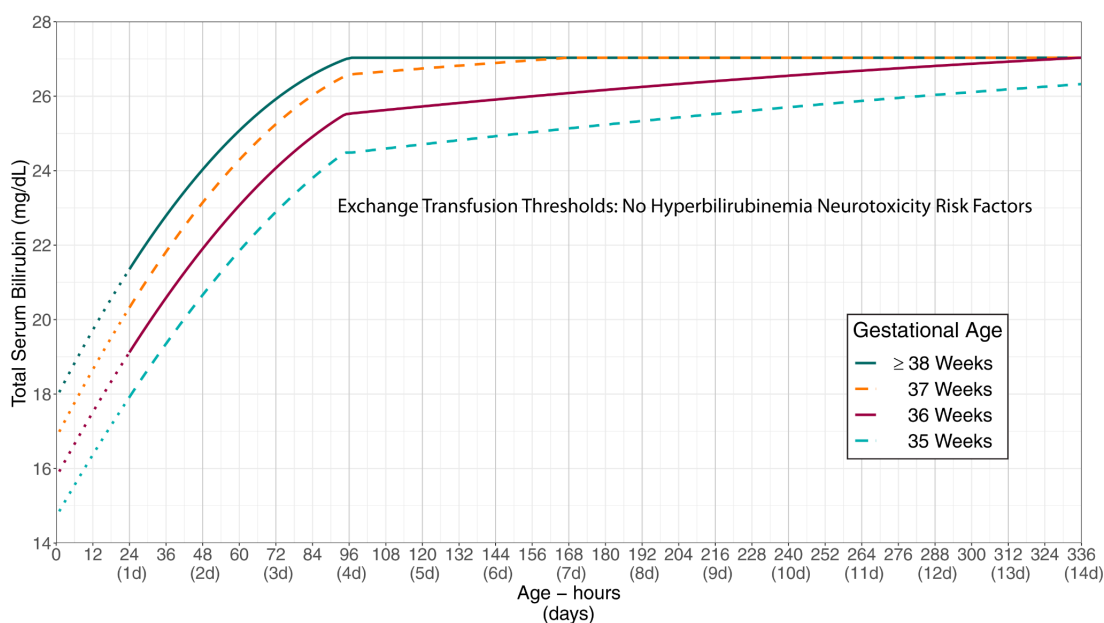
19) Según las **curvas de bilirrubina**, ¿Como es la interpretación de la misma y que **conducta tomamos** ante el paciente? ¿Tiene criterio de **Luminoterapia**? ¿y de **Exanguinotransfusión**?

20) ¿Qué **indicaciones** le damos a Camila? ¿Debe suspender la **lactancia**? ¿Cuándo citamos a **control**?



Umbral de fototerapia por edad gestacional y edad en horas para lactantes sin factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia reconocidos distintos de la edad gestacional.

Utilice las concentraciones de bilirrubina sérica total. Los **factores de riesgo** de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia incluyen: edad gestacional <38 semanas; albúmina <3,0 g/dl; enfermedad hemolítica isoimmune, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) u otras afecciones hemolíticas; sepsis; o cualquier inestabilidad clínica significativa en las 24 horas previas.

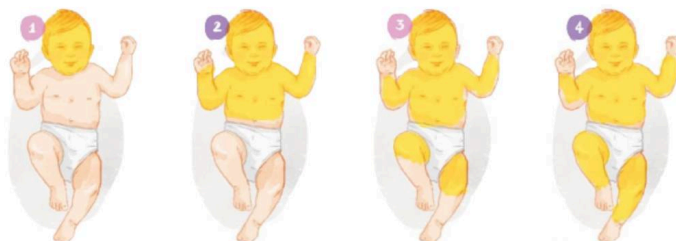


Umbral de exanguinotransfusión por edad gestacional para lactantes sin factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia reconocidos distintos de la edad gestacional

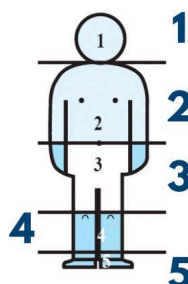
Revisión de la guía de práctica clínica: manejo de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido de 35 o más semanas de gestación. Disponible en: <https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/3/e2022058859/188726/Clinical-Practice-Guideline-Revision-Management-of>



ESCALA DE KRAMER



Zona 1: Ictericidad de la cabeza y cuello = <5 mg/dL
Zona 2: Ictericidad hasta el ombligo = 5-12 mg/dL
Zona 3: Ictericidad hasta las rodillas = 8-16 mg/dL
Zona 4: Ictericidad hasta los tobillos = 10-18 mg/dL
Zona 5: Ictericidad plantar y palmar = >15 mg/dL



Es orientativa.
No reemplaza la medición
sérica o transcutánea de
bilirrubina.



	1	Por favor escriba el número que corresponda al COLOR DE LA MATERIA FECAL de su hijo en el casillero correspondiente, unos días antes del control del 1er mes y no se olvide de llevar esta ficha ese día.
	2	
	3	
	4	
	5	El color de la materia fecal de mi hijo se parece al N° _____ Fecha ____-____-____
Datos		
Nombre y apellido del niño: _____		
HC N°: _____		
Fecha de nacimiento: _____		
Hospital donde nació: _____		
Nombre de la madre: _____		
Fecha de control: _____		
Para completar por el médico		
Cuando la madre elige uno de los números del 1 al 4, por favor observar si el niño presenta: Ictericidad (No, Moderada o Severa). _____		
Color de la materia fecal , comprobada por el médico. N° _____ Fecha ____-____-____		
Si el N° corresponde del 1 al 4, por favor comunicarse lo antes posible con: _____		

Sección Gastroenterología Pediátrica
Hospital Nacional P.A. Posadas - V. Sto. Haedo
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: (011) 4469-9300 int. 1511
Fax: (011) 4469-9220

Cartilla de color de heces del recién nacido.

Herramienta de tamizaje para la detección precoz de colestasis neonatal (atresia biliar).